

Amniorrexe prematura - conduta

RPM = rotura de membranas antes do trabalho de parto. Confirme perda de líquido, estime IG, exclua infecção e balanceie latência (corticoide/ATB) vs interrupção.

Diagnóstico

Dica - Diagnóstico

História de escape líquido + especular (líquido no fundo de saco). Testes auxiliares (pH/nitrazina, IGFBP-1) e oligodrâmnio apoiam. Evite toques repetidos.

Timeline: diagnóstico !' profilaxia e corticoides se prematuro !' parto se termo, infecção ou maturidade conforme protocolo.



Conduta por idade gestacional (ideia)

- Termo ("e37 sem): interromper — indução se sem contraindicação
- Pré-termo: corticoide, ATB de latência, monitoramento de infecção/sofrimento
- Corioamnionite: ATB + interrupção independentemente da IG
- Profilaxia GBS conforme protocolo se em trabalho de parto / cultura

Sinais de corioamnionite

Sinal | Nota

Febre materna | Critério central

Taquicardia materno-fetal | Apoio

Útero doloroso / líquido fétido | Infecção intra-amniótica

Leucocitose | Inespecífico — correlacionar

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Com corioamnionite não se 'prolonga latência para amadurecer pulmão'. Antibiótico e resolução da gestação têm prioridade sobre expectativa.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

RPM: latência, corticóide, antibiótico e tocolítico seguem regras de IG e contraindicações — protocolo clássico de prova.

RPM - regras de conduta

Latencia + corticoide + ATB + tocolise

- 1 Confirmar RPM (liquido / nitrazina / US)
- 2 Corticoide se IG prematura elegivel
- 3 ATB de latencia (ex. ampicilina+azitromicina)
- 4 Tocolitico: so curto p/ corticoide (se indicado)
- 5 Vigilancia infeccao / bem-estar fetal
- 6 Resolver se corioamnionite / TFPP

Infeccao / sofrimento = interromper latencia

Regras que caem

Item | Ideia de prova

Latência | Expectante em IG selecionada sem infecção/sofrimento; ganhando maturidade

Corticóide | Indicado na prematuridade (janela típica ~24–34 sem; siga protocolo local)

ATB | Prolonga latência e reduz infecção — esquema clássico de latência

Tocolítico | Não é tratamento prolongado da RPM; uso breve só se ajudar corticóide/transferência e sem contraindicação

Interromper | Corioamnionite, sofrimento fetal, DPP, trabalho de parto avançado, IG a termo

Toque e conduta

Atencao - Toque e conduta

Evite toques desnecessários (aumenta infecção). Em a termo com RPM: induzir se trabalho não iniciar (tempo conforme protocolo).

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1